

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## ESCALA PSY-FLEX (FLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA ACT)

Eje II: Procesos Psicológicos • Medida de Alta Resolución de los 6 Procesos del Hexaflex de ACT

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Oficial (Español)</b>    | Cuestionario Psy-Flex de Flexibilidad Psicológica.                                        |
| <b>Nombre Original (Inglés)</b>    | <i>The Psy-Flex Questionnaire</i>                                                         |
| <b>Autores Originales</b>          | Drs. Andrew T. Gloster, Jens Gaab et al. (2021), Universidad de Basilea.                  |
| <b>Adaptación Española</b>         | Francisco J. Ruiz, Diana M. García-Martín y María B. Segura-Vargas (2021).                |
| <b>Eje Clínico y Clasificación</b> | Eje II: Procesos Psicológicos. Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Modelo Hexaflex. |
| <b>Tipo de Instrumento</b>         | Autoinforme escalar breve de 6 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).           |
| <b>Población y Rango</b>           | Adultos y jóvenes (desde los 14 años). Apto para evaluación ecológica momentánea (EMA).   |
| <b>Tiempo de Administración</b>    | 1 minuto en autoadministración; 2 minutos asistido.                                       |
| <b>Régimen de Licencia</b>         | Instrumento de acceso abierto para fines clínicos y de investigación académica.           |

### 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO HEXAFLEX

El Psy-Flex fue diseñado por el equipo de Andrew Gloster para superar las críticas metodológicas del clásico AAQ-II (el cual medía principalmente afecto negativo e inflexibilidad, con reactivos redactados negativamente). A diferencia de su predecesor, el Psy-Flex evalúa de manera directa, afirmativa y operacional la **flexibilidad psicológica positiva**: la habilidad de contactar plenamente con el momento presente con apertura a la experiencia interna y cambiar o perseverar en la conducta al servicio de valores elegidos.

Desde una perspectiva neurocognitiva, el Psy-Flex captura la integración dinámica entre tres redes cerebrales mayores: la Red de Saliencia (ínsula anterior y córtex cingulado anterior dorsal, soporte del contacto con el presente y la interocepción), la Red por Defecto (DMN, mediadora de la toma de perspectiva y del Yo-contexto) y la Red de Control Ejecutivo Frontoparietal (córtex prefrontal dorsolateral, regulador de las acciones comprometidas hacia metas). Al medir cada uno de los 6 vértices del hexaflex con un ítem prototípico, ofrece una resolución clínica insuperable con un coste temporal mínimo.

### 3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

| Pilar del Hexaflex              | Ítem   | Rango Dir. | Operacionalización Conductual del Proceso                                                                                           |
|---------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Momento Presente</b>      | Ítem 1 | 1 a 5      | Capacidad de centrar la atención en el aquí y el ahora frente a distracciones mentales en situaciones relevantes.                   |
| <b>2. Aceptación / Apertura</b> | Ítem 2 | 1 a 5      | Disposición activa a experimentar pensamientos y sensaciones displacenteras sin luchar compulsivamente contra ellos.                |
| <b>3. Defusión Cognitiva</b>    | Ítem 3 | 1 a 5      | Toma de distancia crítica frente a pensamientos difíciles; capacidad de ver los pensamientos como eventos mentales y no realidades. |
| <b>4. Yo como Contexto</b>      | Ítem 4 | 1 a 5      | Perspectiva del Yo observador trascendente que permanece estable más allá de los altibajos anímicos transitorios.                   |
| <b>5. Claridad de Valores</b>   | Ítem 5 | 1 a 5      | Conexión clara con lo que resulta profundamente significativo y prioritario en la propia trayectoria vital.                         |
| <b>6. Acción Comprometida</b>   | Ítem 6 | 1 a 5      | Perseverancia en conductas valiosas orientadas a metas personales, incluso en presencia de barreras y dificultades.                 |

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

### 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia Interna</b>         | Elevada homogeneidad: alfa de Cronbach de 0.85 a 0.89 y omega de McDonald de 0.86 a 0.90 en estudios de validación (Gloster et al., 2021; Ruiz et al., 2021).                                                    |
| <b>Estructura Unidimensional</b>    | El AFC confirma un ajuste unifactorial óptimo (CFI = 0.985, TLI = 0.976, RMSEA = 0.038), indicando que los 6 procesos convergen en una dimensión latente general de flexibilidad.                                |
| <b>Validez Concurrente</b>          | Correlaciones positivas robustas con bienestar psicológico general (WHO-5, $r = 0.65$ ), florecimiento personal (FS, $r = 0.62$ ) e inversas con depresión y distrés (PHQ-9, $r = -0.58$ ; GAD-7, $r = -0.54$ ). |
| <b>Validez Incremental</b>          | Muestra validez predictiva incremental sobre el AAQ-II al predecir resiliencia, salud mental positiva y adhesión terapéutica controlando por afecto negativo.                                                    |
| <b>Sensibilidad al Cambio y EMA</b> | Excepcional idoneidad para la medición sesión a sesión y en protocolos de Evaluación Ecológica Momentánea (diarios en smartphones), capturando fluctuaciones adaptativas intradía.                               |

### 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

El sujeto califica cada una de las 6 afirmaciones considerando cómo actúa habitualmente ante las demandas de su vida diaria:

- **Escala de Calificación:** 1 = «Muy rara vez», 2 = «Rara vez», 3 = «A veces», 4 = «A menudo», 5 = «Muy a menudo».
- **Puntuación Total Psy-Flex:** Suma directa de las puntuaciones de los ítems 1 al 6. No contiene ningún reactivo invertido.
- **Rango Teórico: 6 a 30 puntos.** A mayor puntuación, mayor nivel global de flexibilidad psicológica adaptativa.
- **Análisis de Perfil de Ítems:** Además del sumatorio total, el clínico debe inspeccionar la puntuación individual de cada reactivo (1 a 5) para identificar cuál de los 6 vértices del hexaflex presenta mayor déficit operativo (reactivos con puntuación 1 o 2).

### 6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

| Nivel de Flexibilidad    | Puntuación | Estado Psicológico                                          | Enfoque Clínico Recomendado                                                                                       |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baja / Rígida</b>     | 6 a 15     | Inflexibilidad severa ( <b>corte <math>\leq 15</math></b> ) | Déficits múltiples en aceptación, presencia y valores. Indicación de psicoterapia ACT integral y estructurada.    |
| <b>Moderada</b>          | 16 a 22    | Flexibilidad intermedia o inconsistente                     | Capacidad parcial de regulación. El sujeto mantiene metas pero se atasca ante estrés agudo o emociones intensas.  |
| <b>Alta / Adaptativa</b> | 23 a 30    | Flexibilidad psicológica consolidada                        | Excelente repertorio de aceptación, presencia reflexiva y perseverancia orientada a valores. Factor de bienestar. |

#### CRITERIO DE MONITORIZACIÓN BASADA EN MEDICIÓN (MBC):

Un incremento de  **$\geq 4$  puntos** a lo largo del proceso psicoterapéutico refleja un cambio clínicamente significativo en flexibilidad psicológica. Puntuaciones basales  **$\leq 15$**  son altamente predictivas de cronificación en trastornos del ánimo si no se entrena explícitamente la apertura y el distanciamiento de reglas verbales limitantes.

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

### 7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA MODULAR (MAPA DEL HEXAFLEX)

#### INTERVENCIÓN MODULAR DIRIGIDA POR ÍTEMS DEL PSY-FLEX:

- Si **Ítem 1 (Presente) ≤ 2**: Entrenar ejercicios de anclaje sensorial y atención plena para frenar el piloto automático.
- Si **Ítem 2 (Aceptación) ≤ 2**: Trabajar disposición y exposición interoceptiva; desarticular conductas de control y huida.
- Si **Ítem 3 (Defusión) ≤ 2**: Ejercicios de externalización del lenguaje (“tengo el pensamiento de que...”, nombrar a la mente).
- Si **Ítem 4 (Yo-Contexto) ≤ 2**: Metáforas de perspectiva (el cielo y las nubes, el tablero de ajedrez).
- Si **Ítem 5 (Valores) ≤ 2**: Clarificación axiológica profunda (epitafio, brújula de valores de Dahl).
- Si **Ítem 6 (Acción) ≤ 2**: Establecimiento de metas SMART comprometidas paso a paso con monitorización conductual.

### 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: APLICACIÓN EN BURNOUT SANITARIO

**Paciente:** Mujer de 38 años, médica de urgencias, que consulta por agotamiento emocional severo, distanciamiento cínico de los pacientes e insatisfacción con su labor hospitalaria tras dos años de alta presión asistencial.

**Evaluación Cuantitativa Inicial:** Psy-Flex Total = **11 puntos** (Baja flexibilidad; perfil marcadamente rígido).

• **Desglose por Vértice del Hexaflex:** Ítem 1 (Presente) = 2; Ítem 2 (Aceptación) = 1 (rechazo total al malestar y lucha constante contra la culpa); Ítem 3 (Defusión) = 1 (fusión absoluta con la creencia «no puedo cometer ningún fallo jamás»); Ítem 4 (Yo-Contexto) = 2; Ítem 5 (Valores) = 3; Ítem 6 (Acción) = 2.

**Formulación Clínica:** La paciente ha transformado su vocación en una trampa de autoexigencia implacable. La fusión cognitiva y la no aceptación del dolor inherente al trabajo médico la han desconectado de sus valores fundamentales de compasión y cuidado.

**Tratamiento y Resultados:** Se implementó un protocolo ACT abreviado focalizado en defusión del juicio autocrítico y cultivo del autocuidado consciente. A la sesión 8, el Psy-Flex aumentó a **24 puntos** (Ítem 2 subió a 4; Ítem 3 subió a 4), reportando revitalización del contacto vocacional con los pacientes y disminución sustantiva del estrés.

### 9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN TERAPÉUTICA

#### VENTAJA FRENTE AL AAQ-II EN SEGUIMIENTO

El Psy-Flex no confunde afecto negativo con inflexibilidad. Es ideal para monitorizar pacientes con enfermedades médicas crónicas donde el dolor o el malestar somático persisten de manera inevitable, evaluando si logran vivir plenamente pese al síntoma.

#### CAUTELA EN AUTOEVALUACIÓN SUPERFICIAL

En pacientes con alta deseabilidad social o tendencia a la intelectualización, un puntaje artificialmente alto (> 26) puede ocultar una pseudoflexibilidad discursiva no corroborada por acciones comprometidas observables en la vida real.

### 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Gloster, A. T., Block, V. J., Klotsche, J., Villanueva, J., Rinner, M. T., Baur, V., ... & Gaab, J. (2021). The Psy-Flex: A contextually sensitive measure of psychological flexibility. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 22, 13–23.
2. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Acceptance and Commitment Therapy: The process and practice of mindful change* (2nd ed.). Guilford Press.
3. Ruiz, F. J., García-Martín, D. M., & Segura-Vargas, M. B. (2021). Spanish translation and preliminary validation of the Psy-Flex questionnaire. *Konrad Lorenz University / KlinikLab*.
4. Rogge, R. D., Daks, J. S., Dubler, B. A., & Saint, K. J. (2019). It's all about the process: Examining the convergent and incremental validity of psychological flexibility. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 14, 90–101.